

ATESTMED como política pública baseada em evidências

Modelo racionalista, matriz de síntese de avaliação e automação graduada por risco

Mestrado de Políticas Públicas e Governo

Seminário de Análise de Políticas Públicas

Gustavo M. Mendes de Tarso

June 23, 2026

FGV

Capacidade pericial limitada diante de demanda heterogênea

- Fila superior a 90 dias em determinadas localidades.
- Parte dos requerimentos possui duração inferior ao tempo de espera.
- Perícia presencial é recurso escasso.
- Consequências: demora, judicialização, pagamentos prolongados e sobrecarga administrativa.

Mensagem-chave

Pergunta-chave: como reservar a perícia presencial para os casos em que ela realmente produz maior valor decisório?

Problema público

Capacidade pericial limitada distribuída sem priorização suficiente por risco, complexidade e valor esperado da perícia presencial.

Efeitos observados

Fila heterogênea, demora excessiva, judicialização, pagamentos prolongados e sobrecarga da Perícia Médica Federal.

Alternativas possíveis

- Manter o status quo.
- Reforçar ou redistribuir a capacidade pericial.
- Fazer mutirões e ampliar teleperícia.
- Usar ATESTMED com regra fixa.
- Usar ATESTMED estatístico com auditoria por risco.

Modelo racionalista de análise de políticas públicas

1. Diagnóstico do problema.
2. Definição do objetivo.
3. Geração de alternativas.
4. Critérios e indicadores.
5. Projeção de resultados.
6. Comparação e recomendação.

Aplicação ao ATESTMED

Nível da política: a matriz de síntese compara alternativas de desenho institucional.

Nível operacional: o modelo estatístico organiza validação, triagem, auditoria e perícia prioritária.

Mensagem-chave

Política pública → matriz multicritério → modelo estatístico → fluxo graduado por risco

A1 - Status quo

Todos aguardam perícia presencial.

A3 - Faixas estatísticas

Percentis e duração esperada como referência para o fluxo documental.

A2 - Regra fixa

Aprovação documental até um limite genérico de dias.

A4 - Triagem e auditoria

Triagem documental, escore probabilístico, auditoria e perícia priorizada.

Mensagem-chave

Hipótese inicial: A4 tende a oferecer melhor equilíbrio entre celeridade, segurança, equidade e uso da capacidade pericial.

Resultados esperados

Eficiência: perícias poupadas e horas liberadas.

Efetividade: redução do tempo até decisão.

Custo-efetividade: custo por caso corretamente direcionado.

Garantias decisórias

Segurança: divergência identificada em auditoria.

Equidade: erro e espera por perfil e território.

Legalidade: reversões, recursos e nulidades.

Condições de implementação

Viabilidade: custo, sistemas, capacitação e governança.

Simplicidade: tempo de implantação e operação.

Mensagem-chave

A matriz não escolhe a política por um único indicador: ela hierarquiza alternativas a partir de critérios explícitos.

1. Documental

Autenticidade do atestado, assinatura/certificação digital, emissor, campos obrigatórios, duplicidade e consistência de datas.

2. Estatístico

Percentis condicionais, identificação de outliers, probabilidade de divergência, impacto potencial e incerteza.

3. Encaminhamento

Baixo risco + documento íntegro + regra vigente: deferimento documental automatizado com auditoria amostral.

Mensagem-chave

Limite institucional: a automação não produz indeferimento automático; ela regula a intensidade da revisão humana.

Estágio 1 - duração esperada do afastamento

$$Q_{\tau}(D \mid \text{CID, idade, sexo, território, atividade, exposição, histórico laboral})$$

Produce percentis condicionais: P50, P75, P90 e P95.

Estágio 2 - risco de divergência ou necessidade de revisão

$$P(\text{divergência} = 1 \mid X)$$

X inclui duração solicitada, qualidade documental, atividade/CBO, exigências funcionais, tempo na ocupação, histórico de afastamentos e histórico decisório.

Mensagem-chave

A atividade laboral contextualiza a limitação funcional e melhora a comparação estatística; não funciona como rótulo automático de deferimento ou indeferimento.

1. Entrada e validação

Requerimento, atestado digital, CID, dias solicitados, atividade laboral, histórico laboral e dados administrativos.

2. Tratamento automatizado

Autenticidade, completude, padronização de variáveis, cruzamentos autorizados e identificação de inconsistências.

3. Contextualização estatística

Grupo de referência, duração esperada, risco de divergência, impacto potencial e incerteza.

4. Roteamento da decisão

Baixo risco: deferimento documental automatizado + auditoria aleatória.

Médio risco: auditoria documental humana.

Alto risco/incerteza: perícia presencial prioritária.

5. Controle e aprendizado

Auditoria independente, registro de divergências, monitoramento de vieses, recalibração e revisão periódica das regras.

Requerimento hipotético

Rafael (nome fictício), 45 anos, residente em Teresina-PI, trabalha na construção civil há 22 anos. Apresenta CID-10 M54.5 e solicita afastamento de 45 dias.

O requerimento informa atividade/CBO, tempo na ocupação e histórico laboral pertinente; o atestado possui assinatura digital válida.

Grupo estatístico de referência

CID M54.5 + idade + sexo + Teresina/PI + ocupação na construção civil + exigências funcionais + tempo na atividade + histórico de afastamentos.

Premissa ilustrativa: média histórica de 45 dias; a cada 100 pedidos, 96 deferidos, 3 indeferidos em perícia e 1 indeferido por motivo administrativo.

Mensagem-chave

A média de 45 dias não é corte automático: o sistema estima a posição do caso na distribuição e seu risco de divergência.

Passo 1 - integridade documental

Assinatura digital válida, emissor identificável, campos completos e consistência entre dias solicitados, atividade declarada e requisitos administrativos.

Passo 2 - avaliação estatística contextualizada

O sistema estima o percentil dos 45 dias e calcula $P(\text{divergência})$, incorporando duração, documentação, atividade laboral, histórico laboral e incerteza.

Passo 3 - decisão de fluxo

Baixo risco: deferimento documental automatizado, se permitido pela regra vigente, com auditoria aleatória posterior.

Risco intermediário: auditoria documental humana.

Percentil muito alto, inconsistência ou incerteza: perícia presencial prioritária.

Prioridade de revisão = $P(\text{divergência}) \times \text{impacto do erro} \times \text{incerteza}$

Baixo risco

Deferimento documental automatizado, quando a norma permitir, com auditoria aleatória.

Risco intermediário

Auditoria documental humana antes da decisão final.

Alto risco ou incerteza

Perícia presencial prioritária ou revisão humana especializada.

Mensagem-chave

Princípio: o escore automatiza a intensidade do controle; não produz indeferimento automático.

Validação retrospectiva

Treinamento com dados históricos; separação entre treino e teste; calibração do risco; avaliação por subgrupos e estabilidade temporal.

Validação prospectiva

Projeto-piloto, auditoria aleatória e comparação entre unidades ou períodos. Avaliação de fila, custo, erro, equidade e taxa de reversão.

Salvaguardas

Sem indeferimento automático; revisão humana nos casos críticos, atípicos ou incertos; auditoria independente; monitoramento de vieses; governança de dados e explicabilidade; certificação digital.

Mensagem-chave

Custo-efetividade: $CE = \frac{\text{Custo adicional}}{\text{Casos corretamente direcionados}}$.

Tese

O ATESTMED pode ser estruturado como política pública baseada em evidências: a matriz multicritério compara desenhos institucionais, e a estatística organiza a intensidade da revisão.

Resultado esperado

A capacidade pericial passa a ser empregada onde a revisão humana possui maior valor decisório, sem automatizar indeferimentos e com auditoria permanente.

Mensagem-chave

Modelo racionalista + matriz de síntese de avaliação + estatística de risco

Capacidade pericial aplicada onde produz maior valor público.

Referência central

SECCHI, Leonardo. *Análise de políticas públicas: diagnóstico de problemas, recomendação de soluções*. São Paulo: Cengage Learning, 2020.

Apoio conceitual utilizado

Abordagem racionalista: Capítulo 4.

CrITÉRIOS e indicadores: Seção 4.2.

Análise custo-efetividade: Seção 4.3.2.

Comparação e hierarquização: Seção 4.3.5, incluindo a matriz de síntese de avaliação.

Nota metodológica

Os dados e parâmetros do caso de Rafael são ilustrativos. Seu uso requer dados autorizados, validação estatística, avaliação de vieses, governança de dados e aderência à norma vigente.